

MODELLO INFORMATIVO E DI CONSENSO PER L'INTERVENTO DI GLUTEOPLASTICA CON PROTESI

(aumento del volume dei glutei mediante inserimento di protesi glutee)

Io, sottoscritta ho già ricevuto tutte le informazioni utili per prendere una decisione consapevole nei colloqui preoperatori sull'intervento chirurgico di Gluteoplastica con protesi a cui desidero sottopormi e i seguenti punti sono stati ben chiariti dal Prof. Dott. e per i quali ho già espresso il mio consenso verbale.

Ricordo che questo aumento di volume dei glutei si realizza mediante l'impianto di una protesi di gel di silicone fatta appositamente per i glutei. L'intervento viene effettuato per modificare la forma ed il volume dei glutei. Le protesi utilizzate sono costituite da un involucro esterno che racchiude un gel di silicone ad alta coesività e differiscono tra loro per il loro volume, forme (anatomica o rotonda) e misure. L'incisione cutanea può essere effettuata, a seconda della tecnica utilizzata, in corrispondenza del solco intergluteo (una sola incisione mediana e verticale) o appena a lato del solco intergluteo (una incisione per gluteo, totale 2 incisioni parallele). In relazione al singolo caso e della tecnica scelta esse possono essere collocate in una tasca a livello sottofasciale, intramuscolare, o sotto muscolare. Il muscolo in questione è il muscolo grande gluteo, il più grande muscolo della regione del bacino (e del corpo umano) In genere viene scelta il piano sottofasciale quando lo spessore del tessuto sottocutaneo è sufficiente a dare una adeguata copertura alla protesi stessa. Si scelgono i piani intramuscolari o sottomuscolari quando la copertura del grasso sottocutaneo è esigua e nelle donne magre. La scelta della tecnica migliore nel mio caso è stata discussa approfonditamente con il chirurgo. Nei casi in cui ci sia un evidente differenza di volume tra i due glutei, l'intervento può renderle più simili anche se è impossibile ottenere una completa simmetria.

Alternative terapeutiche

Procedura alternativa ed anche integrativa della gluteoplastica con protesi è l'autotrapianto di grasso ovvero l'intervento di lipoin impianto-Lipofilling. Questa tecnica prevede l'utilizzo dell'autotrapianto di grasso e consiste nell'aumentare il volume dei glutei o di una loro porzione con l'impiego di tessuto adiposo prelevato da altre parti corporee. Il volume che si deve aggiungere in occasione di tale autotrapianto è maggiore di quello che rimarrà perché una percentuale del 30-50% di quello che è impiantato si riassorbe nelle settimane successive per mancato attecchimento. In caso di riassorbimento maggiore o asimmetrico, sarà necessario effettuare ulteriori successivi interventi di autotrapianto. All'intervento di Lipofilling possono residuare cisti oleose/noduli anche calcifici. Un limite di questa procedura è che l'aumento di volume che si ottiene con un solo intervento è limitato dalla necessità d'impiantare una quantità di tessuto adiposo di cui ne sia possibile l'attecchimento. In caso di una richiesta di aumento di volume cospicuo di un gluteo piccolo sono necessari più interventi scaglionati nei mesi. Il grasso trapiantato nel gluteo, inoltre, seguirà la sua naturale evoluzione, analogamente al resto del corpo, durante l'ingrassamento o il dimagrimento.

Complicanze post operatorie

La complicanza precoce più frequente è l'ematoma. Se esso tende ad aumentare di volume o è cospicuo è indispensabile evacuarlo e controllare l'emostasi. È possibile che si manifesti anche tra una visita di controllo e l'altra e in caso di aumento di volume improvviso di un gluteo è bene segnalarlo senza indugio ai chirurghi perché prendano immediati provvedimenti del caso. Il trattamento di scelta rimane la sua evacuazione chirurgica.

L'infezione rappresenta una complicanza infrequente che necessita di terapie antibiotiche prolungate. Si può tentare un'accurata toilette chirurgica della tasca protesica con sua disinfezione con antisettici ed antibiotici e reimpiantare la protesi durante il medesimo intervento. Questo tentativo ha la finalità di prevenire il disagio psicologico di vedersi per un periodo di alcuni mesi con una condizione di grave asimmetria glutea. Nel caso in cui con questo tentativo l'infezione non fosse dominata sarà necessario rimuovere la protesi e attendere alcuni mesi, fino a quando si sono normalizzati tutti parametri infiammatori, prima di impiantarla nuovamente. Altra complicanza possibile è l'esposizione della protesi conseguente alla necrosi dei tessuti sovrastanti o deiscenza (riapertura) della ferita per infezione. In questi casi per il trattamento dell'infezione sarà necessario rimuovere la protesi per poi impiantarla nuovamente a distanza di tempo.

Esiti

Nella maggior parte dei casi il gluteo rimane morbido ma in alcuni casi si può avere un aumento di consistenza e di fissità del gluteo con un innaturale aspetto globoso, rigido ed anche dolenzia cronica per un progressivo ispessimento dei tessuti attorno alla protesi (capsula peri protesica). Tale evento, molto raro nel caso della gluteoplastica è ancora non di chiara origine, può insorgere a distanza di mesi o di anni e può comportare la necessità, soprattutto se importante, di un intervento di revisione chirurgica della cavità ed eventualmente una sostituzione della protesi.

Altra complicanza tardiva è il dislocamento dell'impianto (spostamento) che può comportare la necessità di intervenire per effettuare la correzione chirurgica.

Nelle pazienti molto magre, con marcata sottigliezza dei tessuti che ricoprono la protesi, è possibile che si possano apprezzare dall'esterno, soprattutto nei quadranti superiori e laterali, pieghe cutanee che rendano visibile la presenza della protesi. Anche questa evenienza è migliorabile con il trattamento chirurgico. In caso d'impianto della protesi in sede retro muscolare, durante la contrazione del muscolo gluteo (nell'esecuzione di un affondo o squat), si possono rendere evidenti dei movimenti del gluteo e della protesi (deformità dinamica).

In caso che si utilizzino protesi anatomiche è possibile che si verifichi la rotazione della protesi fino alla sua completa inversione del polo superiore con quello inferiore. Tale fenomeno, se si ripete, spesso necessita di una correzione chirurgica. Anche la rotazione in senso antero-posteriore (flip) è stato descritto.

È possibile che si manifesti un rovesciamento in senso antero-posteriore della protesi stessa con dolenzia e deformazione estetica. Anche in questo caso si può effettuare un intervento di correzione chirurgica.

Rottura della protesi: le protesi glutee hanno generalmente una durata di anni ma nessuna è per sempre poiché la parete esterna si usura lentamente a contatto dei tessuti. La rottura protesica può essere confermata dalla risonanza magnetica nucleare eseguita in posizione prona. La durata delle protesi si accorcia per usura soprattutto nelle donne sportive o con intensa attività fisica che espongano la protesi a traumi diretti. In caso di rottura si deve procedere alla sostituzione della protesi.

Ricordo che nei colloqui che hanno preceduto la data dell'intervento mi sono stati ben chiariti i seguenti punti sulle tecniche, sui limiti e complicanze e per i quali ho già espresso il mio consenso verbale:

1. Le protesi glutee sono un Dispositivo Medico altamente Biocompatibile che, normalmente, sono ben accettate dai tessuti, sono soggette ad usura e nel tempo andranno sostituite.
2. Il gluteo è costituito da tessuti molli e muscolari che si modificano nei mesi e negli anni, con l'ingrassamento e il dimagrimento e comunque il naturale invecchiamento del gluteo altera il risultato estetico. Dopo alcuni mesi o anni dall'intervento, si può verificare un "assestamento" dei tessuti molli del gluteo che può render necessario ritocco chirurgico di correzione e di ripristino dell'estetica alterata.
3. Ho ben presente che i due lati del corpo umano non sono uguali e che non potranno mai essere resi identici, specialmente in presenza di asimmetrie di posizione dei glutei o del loro volume iniziale. Si possono attenuare difetti di varia natura ma coloro che si aspettano trasformazioni eclatanti molto spesso sono destinate a delusioni inevitabili.

4. Il miglioramento dopo l'intervento è subito visibile ma il risultato subirà delle naturali evoluzioni e si può considerare apprezzabile in modo pieno dopo circa sei mesi, con l'assestamento dei tessuti e l'ammorbidimento delle cicatrici. Eventuali cicatrici inestetiche possono essere corrette con trattamenti medici da effettuare nei primi mesi o con un intervento dopo almeno 6 mesi dopo l'operazione anche se bisogna tener presente che non in tutte i casi si può ottenere una elevata simmetria tra la parte destra e sinistra per l'imprevedibile assestamento post chirurgico dei tessuti.

5. Dichiaro di essermi attenuta con scrupolo all'osservanza del divieto del fumo e ciò è importante al fine di ridurre i fattori aggiuntivi di rischio di complicanze. Dichiaro di aver interrotto il fumo da almeno da 7 giorni prima dell'intervento e che non fumerò per almeno per i 15 giorni successivi all'operazione come da prescrizione datami alla visita.

6. Dichiaro, inoltre, di non aver assunto gli antiaggreganti piastrinici, l'acido acetilsalicilico, analgesici e antinfiammatori (Aspirina, Aspirinetta, Vivin C, Aulin, ecc.) da almeno 10 giorni prima dell'intervento.

7. Con l'intervento di Gluteoplastica con protesi, come nel caso di qualsiasi altra procedura chirurgica, si possono sempre manifestare complicanze o esiti sfavorevoli non eliminabili a priori, dovute al rischio intrinseco nell'intervento, complicanze che sono previste nella Letteratura Scientifica Internazionale e che sono, statisticamente, destinate comunque ad accadere. Se il mio organismo non la tollerasse, ad esempio con la formazione di tessuto cicatriziale eccessivo attorno alla protesi (retrazione capsulare) con un indurimento dei glutei (3-8%) con deformazione dura e a "palla" del gluteo, asimmetria non compatibile con il risultato estetico, esse dovranno essere sostituite con altre. Solo in rari casi si dovrà rimuoverle definitivamente con cicatrici e conseguenze negative sia dal punto di vista psicologico che sull'aspetto estetico.

8. Durante i movimenti delle cosce o per la contrazione intensa del muscolo grande gluteo la forma del gluteo e della protesi si può deformare in modo più o meno evidente e si può manifestare quello che è definita la "deformità dinamica" del gluteo.

9. Le foto o le immagini generate dal computer in 2D e 3D che lei può aver visto durante la sua visita, con le ipotesi di cambiamento della forma e del volume dei glutei sono immagini virtuali. Le ricordo che il risultato di qualsiasi cambiamento chirurgico dei glutei è altamente dipendente anche dalla reazione dei tessuti alla chirurgia e dalla reazione dei tessuti alle stesse protesi (retrazione cicatriziali, retrazione capsulare ecc.), per cui il risultato finale può avere importanti differenze con le immagini. Esse, quindi, rappresentano solo un'ipotesi e non viene prestata garanzia implicita o esplicita di un determinato risultato.

Il posizionamento della protesi può avvenire nello spazio presente tra muscolo grande gluteo e medio gluteo (tecnica retromuscolare) così come all'interno dello spessore del muscolo grande gluteo (tecnica intramuscolare). In entrambi i casi la vicinanza del nervo sciatico (il nervo che raccoglie la sensibilità dell'arto inferiore) può provocare in rari casi una compressione di esso con conseguente sciatalgia (dolore irradiato alla gamba e al piede) e ancor più raramente paralisi dello stesso, anche permanente. Nel caso di un aumento della

pressione della loggia muscolare adiacente vi è la possibilità di comparsa di una sindrome compartimentale (compressione muscolare) con necessità di intervento chirurgico di fasciotomia d'urgenza. Entrambe le condizioni si risolvono con la terapia medica. Se la compressione del nervo è determinata dalla presenza di un ematoma vi è la possibilità di dover procedere ad un re-intervento per evacuare il sangue accumulato. In una piccola percentuale di casi (<5%) a distanza di tempo (anni) la protesi può andare incontro a rotazione, evenienza risolvibile con la manipolazione dell'impianto da parte del chirurgo. Se si dovesse ripresentare in più occasioni la soluzione è la rimozione dell'impianto.

10. So che la protesi nel gluteo può essere visibile e palpabile specialmente sui bordi, soprattutto laterali ed inferiori.

11. Poiché la Chirurgia è una Scienza ma non esatta non lo è neanche la Chirurgia Plastica Estetica: i risultati sono prevedibili solo in modo statistico e non in assoluto perché sono molti i fattori biologici individuali che sfuggono al controllo e possono condizionare l'esito per cui non può essere garantita un'obbligazione di risultato.

12. Nel caso in cui, per imprevedibili complicanze, esiti, anomalo assestamento dei tessuti operati o cicatrici non estetiche, si renda necessario un intervento chirurgico secondario o un semplice "ritocco" il costo di tali procedure, accertamenti, materiali e della clinica, ecc. sono a carico del/della Paziente.

13. La sensibilità della cute dei glutei potrà rimanere alterata, esagerata in modo doloroso o assente, per un periodo variabile, raramente in forma stabile.

14. Talvolta, anche spontaneamente o dopo un semplice trauma, può comparire anche dopo anni un sieroma attorno alla protesi ovvero un aumento di volume di un gluteo conseguente al liquido prodotto dai tessuti attorno alla protesi. Il trattamento deve essere stabilito dal chirurgo e può variare dal semplice riposo, alla assunzione di farmaci anti infiammatori, all'aspirazione del liquido con siringa, fino alla necessità di un intervento per sostituire la vecchia protesi con una nuova.

15. In alcuni pazienti si può riscontrare, a distanza di tempo dall'intervento, la presenza di un accumulo di liquido intorno alla protesi. Nonostante molti di questi casi siano di natura essenzialmente post-traumatica, è importante che questi pazienti vengano studiati accuratamente, in quanto recentemente è stata definita una patologia denominata GI-ALCL (Linfoma anaplastico a grandi cellule associato a impianto gluteo) che può presentarsi in rarissimi casi di pazienti portatrici di un certo tipo di protesi glutee. Attualmente, a fronte di milioni di protesi impiantate, il numero di casi di questa patologia appare estremamente limitato. La maggior parte di queste pazienti guarisce attraverso l'asportazione delle protesi e delle capsule cicatriziali intorno ad esse. In rarissimi casi è stata riscontrata una più grave malattia metastatica.

16. Acconsento alla somministrazione di anestesia generale, locale e con sedazione e so che ci sono sempre rischi per la vita e per la salute conseguenti all'anestesia. Autorizzo oltre che i chirurghi anche gli anestesisti a modificare secondo scienza e coscienza i procedimenti chirurgici programmati ed anche interromperli in caso lo reputino opportuno.

17. Ai sensi della legge sulla Privacy (n° 675 del 31.12.1996 e successive modifiche) e del General Data Protection Regulation europeo Gdpr n°679/2016 entrato in vigore il 25 maggio del 2018) conferisco il consenso ad effettuare su di me fotografie e/o riprese video preoperatorie, intraoperatorie e postoperatorie, che saranno archiviate anche in vista delle successive visite di controllo per poter valutare l'evoluzione dell'intervento, dei processi di guarigione. Questo conferimento di consenso all'utilizzo dei dati è indispensabile per poter usufruire delle prestazioni.

18. Ai sensi della suddetta legge sulla Privacy (n° 675 del 31.12.1996 e successive modifiche) e del General Data Protection Regulation europeo Gdpr n°679/2016 entrato in vigore il 25 maggio del 2018) consento l'utilizzo delle suddette fotografie per scopi scientifici per congressi medici, pubblicazioni a mezzo stampa ed anche digitale, su siti internet, per utilizzo con finalità divulgativo, didattiche, scientifiche, con la garanzia dell'anonimato. Questo conferimento di dati è facoltativo e l'autorizzazione è revocabile con le modalità e

forme e i limiti di cui al regolamento per la tutela della privacy adottato dallo studio consultabile presso la Direzione della struttura ed è regolato dal consenso sul trattamento dei dati da me già sottoscritto¹⁹.
Dichiaro di non essere in "stato interessante". Il lavoro e le attività sociali dovranno essere ridotti per almeno due settimane dopo l'intervento.

20. La guida non potrà essere ripresa prima di 10 giorni dall'intervento. L'attività sessuale dovrà essere sospesa nelle prime due settimane. Le attività sportive non potranno essere riprese prima di un mese.

21. Ricevo il foglio con la terapia medica domiciliare e le istruzioni post-operatorie e ad entrambi mi impegno ad attenermi con scrupolo

Come giudica le informazioni a lei fornite sia verbalmente che nel presente modello informativo e di consenso?

Ho avuto tempo e modo di porre a proposito tutte le domande che ho ritenuto opportune sul trattamento proposto, ho ottenuto in merito risposte esaurienti che ho compreso pienamente e che mi hanno soddisfatto. Dichiaro che, valutate le terapie alternative che mi sono state proposte e spiegate sia verbalmente che riassunte nel presente modello informativo, di voler scegliere l'intervento di Gluteoplastica con protesi. Sulla base di quanto comunicatomi ed in piena libertà di giudizio confermo che:

NON ACCONSENTO.....

SI, ACCONSENTO

Per specifica accettazione ed autorizzazione del punto n°22 del presente documento, relativo alla legge sulla Privacy (n° 675 del 31.12.1996 e successive modifiche) e del General Data Protection Regulation europeo Gdpr n°679/2016 entrato in vigore il 25 maggio del 2018) regolato in base al consenso per la tutela della privacy e la protezione dei dati da me sottoscritto.

NON ACCONSENTO

SI, ACCONSENTO

Firma del Medico che ha informato

Data,